



CONDUITE A TENIR DEVANT DES VOMISSEMENTS



Plan du cours

I-INTRODUCTION

II-RECONNAITRE LES VOMISSEMENTS

III-DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

IV-COMPLICATIONS

V-DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE

VI-TRAITEMENT

VII-CONCLUSION



Introduction

A. Définition

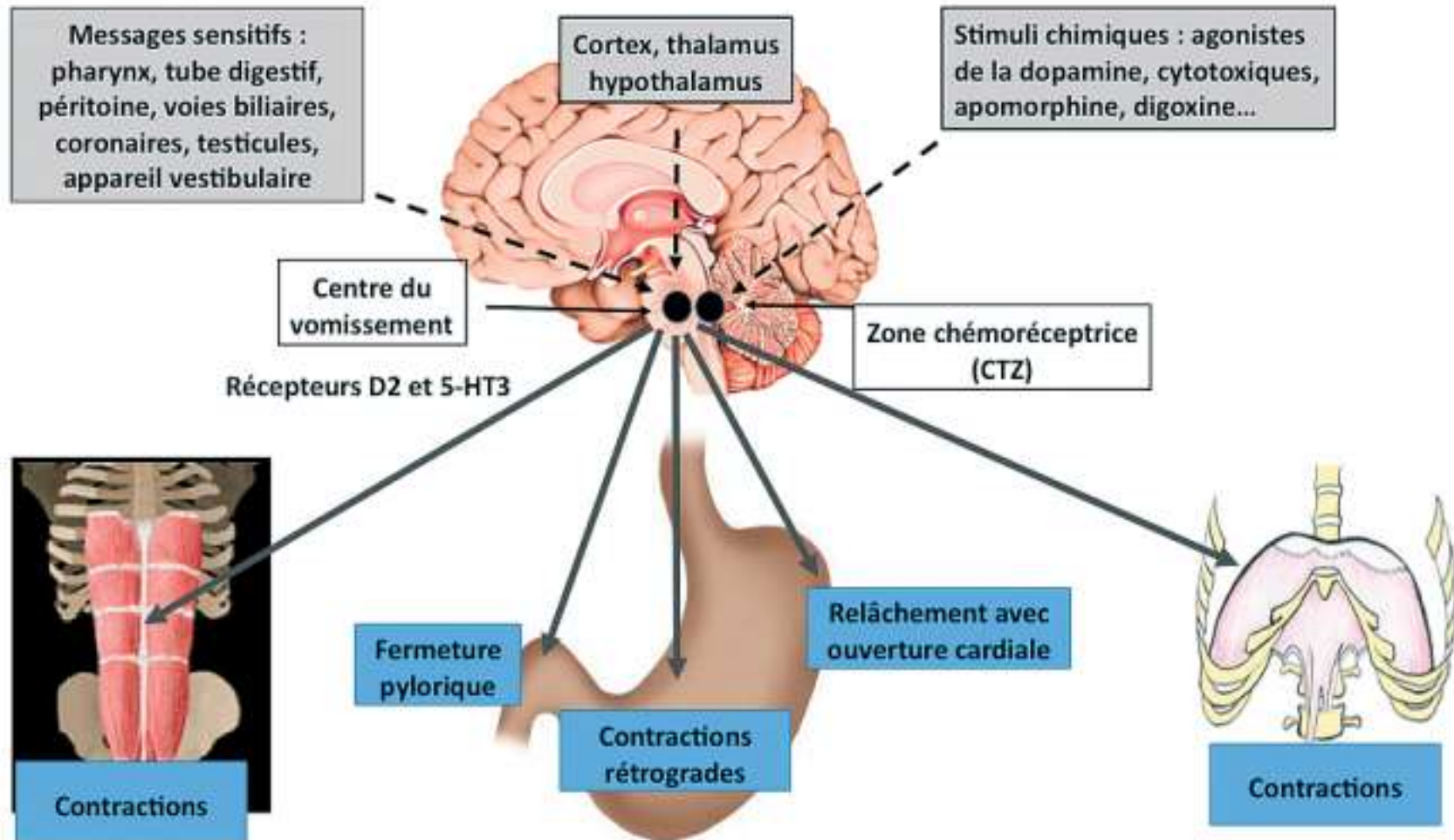
- Rejet **actif** par la bouche d'une partie ou de la totalité du contenu gastrique
- Précédé ou non de nausées
- Nausée: sensation subjective, désagréable, non douloureuse qui précède le besoin de vomir



B. Intérêt de la question

- Motif de consultation fréquent
- Diagnostic facile
- Etiologies multiples

PHYSIOPATHOLOGIE





Reconnaitre les vomissements

- Facile à reconnaître
- S'accompagne souvent d'une hyper activité du système nerveux végétatif : pâleur, sueurs, hypotension, bradycardie



Diagnostic différentiel

-Régurgitation:

Rejet passif par la bouche du contenu gastrique sans Contractions douloureuses des muscles abdominaux et du diaphragme

-Rumination:

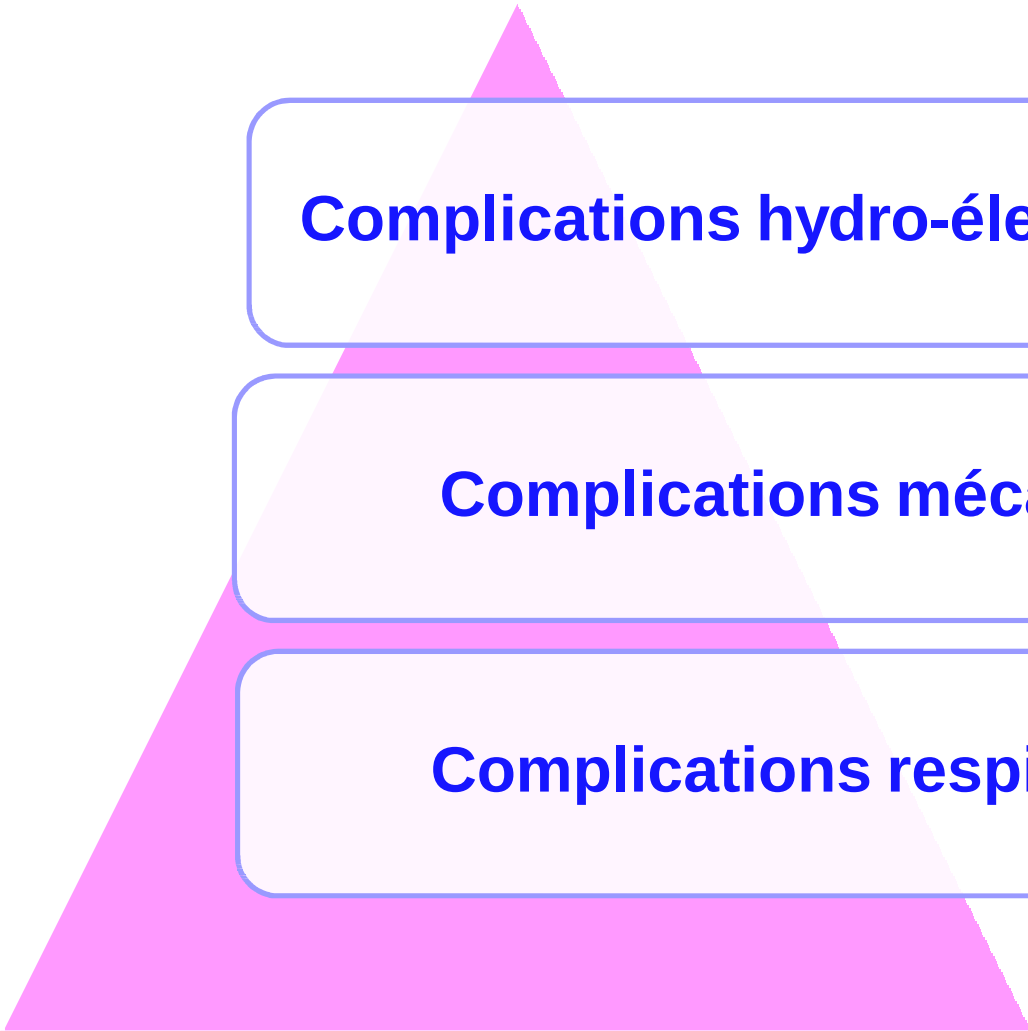
Remontée volontaire du contenu gastrique dans la bouche où il est mastiqué à nouveau

-Pituite:

Rejet de liquide filant survenant le matin (stt alcoolique)



Complications



Complications hydro-électrolytiques

Complications mécaniques

Complications respiratoires



1) Complications hydro-électrolytiques:

- ▲ Clinique: déshydratation extra cellulaire, dénutrition, asthénie profonde
- ▲ Biologie: troubles ioniques, hémococoncentration, IRA, alcalose métabolique
- ▲ Traitement: repose sur la correction des troubles hydro électrolytiques



2) *Complications mécaniques*

➤ *Syndrome de MALLORY-WEISS*

- Déchirure longitudinale de la muqueuse du cardia
- Vomissements répétés alimentaire ou bilieux et hématurie d'abondance variable
- Diagnostic: endoscopie digestive haute

VE 3232003

M 42
07/28/1960

05/31/2003
13:33:35

CVP:
D.F:
6:8 0:H

DR. MARTINEZ
DR. MURRA SACA



➤ ***Rupture spontanée de l'œsophage
(syndrome de BOERHAAVE)***

- Se voit après un effort violent de vomissement
- Douleurs thoraciques intenses irradiant vers l'épaule gauche, Détresse respiratoire + état de choc, dysphagie, odynophagie et des signes de médiastinite
- TLT** et **TDM thoracique**: pneumo-médiastin
- TOGD**: siège exact de la perforation



-La FOGD est contre indiquée

-Traitement repose sur la chirurgie + réanimation intensive

- Avant 24h:traitement est conservateur(suture de la brèche)
- Au delà de 24h,œsophagectomie ou exclusion œsophagienne



➤ *Hématome intra mural de l'œsophage*

- Douleur rétro sternale+ dysphagie récente
- Diagnostic: Endoscopie haute
- Traitement: médical, si échec ou complication =>
Chirurgie

➤ *Œsophagite peptique*

- patients ayant des vomissements répétés
- Dysphagie douloureuse, hématemèse
- Diagnostic: FOGD



3) *Complications respiratoires*

Pneumopathie d'inhalation

- **Syndrome de Mendelson**: survenant chez un sujet inconscient ou alité → Aspiration douce du contenu gastrique



Diagnostic étiologique

- Vomissements aigus
- Vomissements chroniques



1) Vomissements aigus

A. Enquête étiologique

Interrogatoire

Il doit préciser les caractéristiques des vomissements

Caractere: Aigus ou chroniques ?

Nature: alimentaires ou bilieux, fécaloïdes (orientent vers une occlusion), sanglants...

En jet, => hypertension intracrânienne ++

Horaire post-prandial : évoque une sténose digestive haute

Pour l'orientation étiologique

- Date de dernières règles,
- médicaments
- ATCD récent de traumatisme crânien, signes neurologiques associés
- Diabète, intoxication alcoolique



L'examen clinique: doit rechercher

RETENTISSEMENT

Terrain : sujet âgé , diabétique, insuffisance rénale chronique

Signes de déshydratation : pli cutané, poids ++, soif, pouls et pression artérielle

SIGNES ASSOCIES

Fievre

Syndrome confusionnel, céphalées

Douleurs abdominales

EXAMEN PHYSIQUE

Rechercher un syndrome méningé, des signes de localisation neurologique

Syndrome occlusif :touchers pelviens, orifices herniaires



Examens complémentaires : en fonction de l'orientation clinique

- **En urgence : Ionogramme, urée, créatinine**
- Si suspicion d'une urgence chirurgicale: ASP en urgence
- bilan biologique (enzymes pancréatiques), échographie abdominale(voire TDM),
- Exploration cardiaque : ECG, dosage des CPK, LDH
- Exploration neurologique : TDM cérébrale, FO, PL



B. Etiologies

1) Causes digestives :

⇒ Urgences médico-chirurgicales

- Occlusion intestinale aigue
- Péritonite aiguë
- Infarctus mésentérique
- Appendicite aigue
- Pancréatite aiguë ou poussée de PC
- Colique hépatique et ses complications

→ ***Causes médicales***

- Intoxication alimentaire
- Gastro-entérite aiguë
- Hépatite aiguë



2) Causes extradigestives :

Causes médicamenteuses

- Chimiothérapie
- Radiothérapie
- Digitaliques
- Antibiotiques(macrolides, metronidazole)
- Antituberculeux
- AINS/5ASA

Intoxication alcoolique

Intoxication au CO



Causes neurologiques

- Méningite
- Hémorragie méningée
- HIC
- Migraine
- Syndrome vestibulaire



Causes métaboliques et endocriniennes:

- Acidocétose diabétique:
- Insuffisance rénale aigue
- Insuffisance surrénale aigue
- Hypercalcémie
- Dysthyroidie

Causes gynécologiques:

- Grossesse extra uterine
- Salpingite
- Torsion d'un kyste ovarien



Causes cardiaques

-IDM

Autres

glaucome aigu, mal de transport, , colique

Néphrétique, rétention d'urines, hématome rétro
péritonéal



2) Vomissements Chroniques

A. Enquête étiologique

Interrogatoire

- Vomissements pendant plus de 7 jours
- Caractères des vomissements
- Terrain
- Signes d'orientation

Examens complémentaires

- FOGD(biopsies)+++**,ASP,TOGD, écho abdominale voire TDM
- Si (-) => exploration fonctionnelle

TDM et IRM Cérébrale



B. Etiologies

1) Causes digestives

- **Sténose antro-pylorique ou duodénale**
- Vomissements post prandiaux tardifs
- Clapotage à jeun
- Sensation de plénitude épigastrique
- FOGD + biopsies**
- Etiologies: Ulcère bulbaire ou antrale
 Kc gastrique
 Compression extrinsèque



➤ Sténose du grêle:

- Notion de tableau sub occlusif
- Vomissements bilieux
- Météorisme abdominal
- ASP/ Transit du grêle/ EntéroTDM/entéroscopie poussée+ biopsies
- Etiologies
 - Tumorales: lymphomes, ADK, Tm endocrines
 - Inflammatoire: maladie de CROHN
 - Tuberculose, sténose médicamenteuse, entérite radique
 - Extrinsèques: carcinose péritonéale, brides post-operatoires



➤ **La Gatroparésie :**

- Trouble fonctionnel digestif
- FOGD: stase sans sténose
- TOGD

-Scintigraphie gastrique réalisée par un repas marqué

-Causes:

- Diabète
- Amylose digestive
- Sclérodermie
- Lupus érythémateux disséminé
- Idiopathique



➤ **Pseudo obstruction intestinale chronique :**

- Sub occlusions à répétition entrecoupées de périodes de rémission de durée variable
- ASP: Niveaux hydro aériques
- Diagnostic : faisceau d'argument: clinique, morphologique, **manométrique (+++)**
- Causes :
 - Endocriniennes: hypothyroïdie, hyperparathyroïdie, Phéochromocytome, diabète
 - Neurologique: parkinson
 - Musculaire
 - Primitive



2) Causes extra digestives

➤ Causes neurologiques:

- Migraine

- HIC

➤ Causes psychogènes

- Anorexie mentale

- Hystérie



Cas particuliers: Grossesse

Les vomissements du premier trimestre : habituellement non pathologiques, s'ils retentissent sur EG=>hyperemesis gravidarum: correspond aux vomissements gravidiques incoercibles du premier trimestre. Ces vomissements entraînent un amaigrissement et des troubles électrolytiques.



2) La stéatose hépatique aiguë gravidique

- Rare mais potentiellement mortelle (3eme Trimestre)
- Nausées + vomissements
- Douleurs abdominales en particulier épigastriques
- Polyurie et une polydipsie
- Ictère, HTA, protéinurie sont fréquentes
- Le traitement repose sr l'extraction foétale
- En l'absence de traitement, on peut avoir une évolution vers l'encéphalopathie hépatique

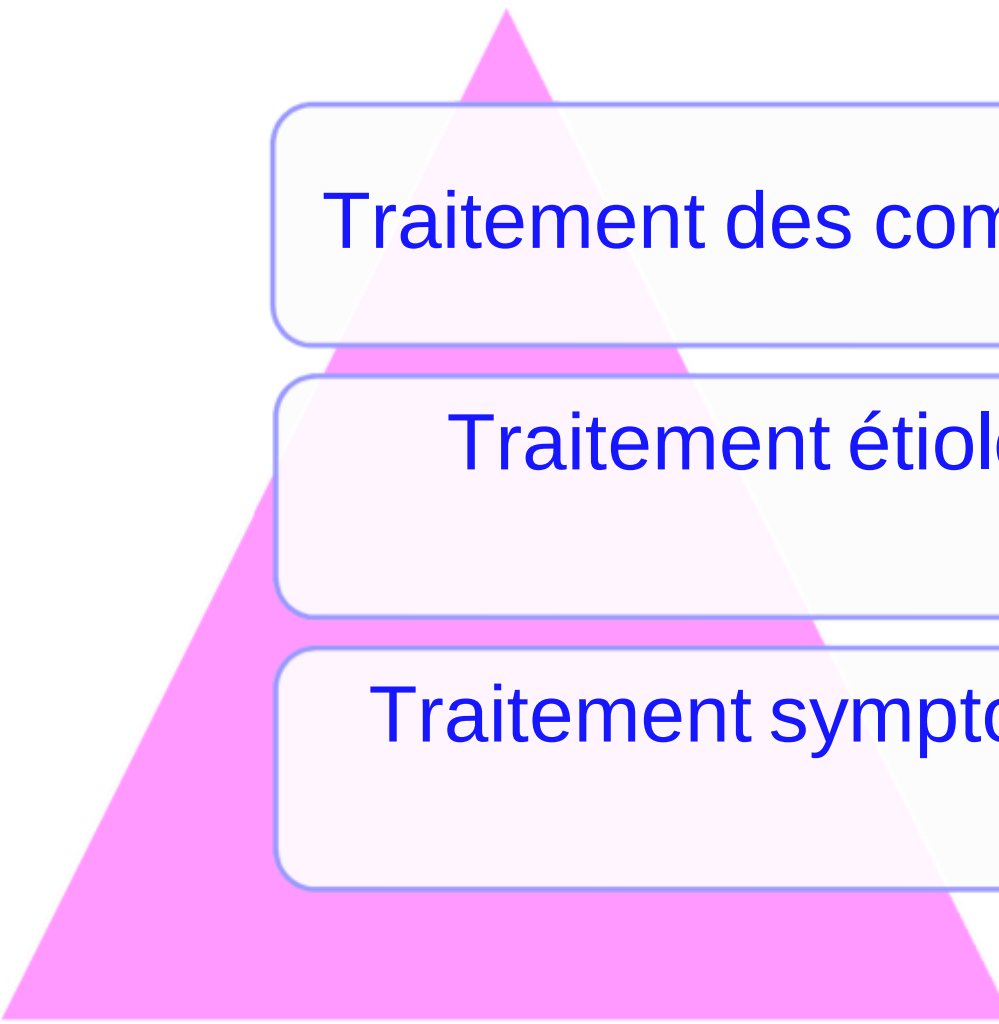


3)Pré éclampsie

- HTA+ protéinurie $> 0,3$ g/24h (3eme Trimestre)
- Les lésions hépatique sont secondaires à des dépôts intravasculaires de fibrine situés principalement au niveau des sinusoides péri portales
- Traitement : évacuation utérine



Traitement des vomissements



Traitement des complications

Traitement étiologique

Traitement symptomatique



trois classes de médicaments:

Médicaments à action centrale pure:

Antihistaminiques H1: diphényldramine, alizapride, métopimazine.

Médicaments à action centrale et périphérique:

✓ Antidopaminergiques: metoclopramide, dompéridone

✓ Inhibiteurs des récepteurs 5-HT₃ de la sérotonine: sétrons (ondansétron, granisétron)

Médicaments à action périphérique pure:

-Cholinergiques spécifiques: cisapride.

-Agoniste de la motiline: érythromycine

1) Traitement symptomatique

Tableau 6. – Principaux médicaments antiémétiques

Action	DCI	Nom commercial®	Formes
Action centrale			
Antihistaminique H ₁	Diphénhydramine	Nautamine Dramamine	p.o. p.o.
Phénothiazines	Alizapride	Plitican	p.o. i.m. i.v.
	Métopimazine	Vogalène	p.o. i.m. i.v.
Butyrophénones	Chlorpromazine	Largactil	p.o. i.m. i.v.
	Halopéridol	Haldol	p.o. i.m. i.v.
	Dropéridol	Droleptan	i.m. i.v.
Action centrale et périphérique			
Antidopaminergique	Métoclopramide	Primpéran	p.o. i.m. i.v.
		Anausin	p.o.
	Domperidone	Motilium	p.o.
		Péridys	p.o.
Antisérotoninergique	Ondansétron	Zophren	p.o. i.v.
	Granisétron	Kytril	p.o. i.v.
	Tropisétron	Navoban	p.o. i.v.
Action périphérique			
Cholinergique spécifique	Cisapride	Prepulsid	p.o.
Agoniste de la motiline	Érythromycine	Érythrocline	p.o.



Conclusion

- motif fréquent de consultation
- Etiologies diverses
- On distingue les vomissements aigus et chroniques
- Le traitement repose sur un traitement des désordres hydro électrolytiques, symptomatique et étiologique

Vomissements: Rejet actif par la bouche d'une partie ou de la totalité du CG

Eliminer: régurgitation, rumination

Dépister et traiter une éventuelle complication

Troubles hydro-électrolytiques, respiratoires, mécaniques

Vomissements aigus

Causes digestives

- Urgence médicochirurgicale
- Causes médicales

Causes extra-digestive

- Toxiques
- Neurologiques
- Métaboliques
- ORL, autres

Vomissements chroniques

Causes digestives

- Sténose pyloro-duodénale
- Sténose chronique du grêle
- Troubles de la MGI

Causes extra-digestive

- Neurologiques
- Psychiatriques

Grossesse

- Hyperemèsis
- gravidarum:1^{er} T
- Stéatose:3^{eme}T hépatique
- Pré-éclampsie:3T

Hospitalisation si DSH, Troubles HE, prise orale impossible, terrain à risque

TRT de la cause/TRT symptomatique par antiémétiques: prokinétiques, neuroleptiques, sétrons



MERCI POUR VOTRE ATTENTION